

单纯前列腺切除术

WARWIKI

患者须知 · 针对很大的前列腺增生（BPH）的手术

单纯前列腺切除术是治疗良性前列腺增生（BPH）导致很大的前列腺阻塞尿流的手术。外科医生经腹部切口（开放式或机器人/微创）切除前列腺内层增生的肥大组织，解除梗阻。该手术对大体积前列腺非常有效。

重要区别

「单纯」前列腺切除术与治疗前列腺癌的「根治性」前列腺切除术**完全不同**。根治性手术是为治疗癌症而切除整个前列腺。**单纯**前列腺切除术仅切除内层增生的良性腺体，保留外层包膜——它治疗的是**非癌性增生引起的梗阻**。

适用情况

- 前列腺**体积很大**，不适合标准内镜手术（TURP）
- 尤其适用于同时合并**膀胱结石**或大型膀胱憩室需一并处理时
- 针对大体积前列腺的内镜选择（**HoLEP**、**Aquablation**）也是备选方案——请遵从您的医生建议

名词解释

单纯前列腺切除术

切除增生的前列腺内层腺体以治疗BPH（非癌症手术）。

腺体（adenoma）

被切除的前列腺内层良性增生组织。

根治性前列腺切除术

为治疗癌症而切除整个前列腺的另一种手术。

开放式 vs. 机器人

经一个切口，或经数个小孔微创操作。

逆行射精

干性高潮——常见的术后影响。

导尿管

术后数日内引流膀胱的管子。

会疼吗？ 手术在全身麻醉下进行，术中无痛感。由于是腹部手术，恢复时间**比内镜手术更长**——通常需住院数天（机器人手术较短）、留置导尿管数天，并限制活动数周。

如何准备

- 需**全身麻醉**——遵从禁食及用药指示（按医嘱停用抗凝药）。
- 术前行**尿液检查**，排除感染。
- 戒烟；安排术后接送及居家照护。

手术过程及术后

- 1 您将处于睡眠状态；同时给予抗生素。
- 2 经腹部切口（开放）或机器人微创入路，切除前列腺内层肥大腺体，保留外层包膜。
- 3 放置导尿管（有时另置引流管）；住院数天（机器人手术较短）。
- 4 导尿管通常保留**数天至约一周**。

术后初期尿液可能带血；**数周内避免重体力劳动和用力屏气**。

术后预期

- 尿流量明显且持久改善。
- **逆行射精**（干性高潮）较常见；对勃起或控尿的严重影响则较少见。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 拔除导尿管后**无法排尿**
- **大量出血或血块**，或发热/寒战
- 腹痛加重，或伤口发红/渗液
- 胸痛、呼吸困难，或腿部肿胀疼痛（紧急情况）

需要记住的三件事

1. 单纯前列腺切除术切除很大BPH的内层腺体——它**不是**癌症手术（癌症手术切除整个前列腺）。
2. 对大体积前列腺非常有效；恢复时间**比内镜手术（HoLEP/Aquablation）更长**。
3. 预期会有干性射精，并需留置导尿管数天。如无法排尿、大量出血或发热，请立即就医。